

NOTULEN

HARI / TANGGAL : KAMIS / 12 MARET 2026

PEMIMPIN RAPAT : dr. SADI HARIONO, M.MRS

PUKUL : 08.30 WIB – SELESAI

NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM

AGENDA RAPAT : LAPORAN BULANAN RUMAH SAKIT

TEMPAT : HALL SAKURA LT 5 PHM

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1	Sambutan komisararis utama - Efisiensi keuangan - Efisiensi gizi - Penggunaan Alat medis di Rumah Sakit	1. RS Prima Husada Sukorejo banyak pengeluaran sehingga presentase keuntungan tidak maksimal → analisis di lapangan pembelanjaan farmasi tinggi terutama di obat paten 2. Sentralisasi makanan melalui MBG → lebih efisiensi 3. Alat phaco di Malang rusak	1. Pembelanjaan obat RS Prima Husada Sukorejo → disamakan dengan Prima Husada Malang - Direktur dan kabid kolaborasi untuk stop pembelian obat obat paten yang tidak sama dengan RS Prima Husada Malang - Evaluasi lebih lanjut 2. Wacana sentralisasi dapur 3 RS setelah adanya evaluasi dari operasional MBG 3. Diharapkan seluruh alat nantinya ada back up	1. Manajerial RS Prima Husada Sukorejo 2. Manajerial PT 3. Manajerial seluruh RS
2	RS Dharma Husada Probolinggo	1. Sistem proporsi 2. IMP Klinis 3. Visitasi dokter umum	1. Sistem proporsi harus dicarikan Solusi: - Efisiensi dari obat - Evaluasi dalam rawat luka - Evaluasi Tindakan operasi	1. Manajerial PT (SE visite DPJP) 2. Manajerial RS

			- Dokter umum tidak diperkenankan visite pasien BPJS. Untuk pasien non BPJS bisa diformulasikan tarifnya, menyesuaikan kemampuan RS - IMP Klinis → integrasikan dan jalankan sesuai akreditasi - Supervision of other normal pregnancy → rawan audit klinis di kembalikan analisis lebih lanjut terkait coding dx nya - Optimalisasi pengkategorian obat kronis dan non kronis, sosialisasi ke DPJP - Sharing kompetensi → aktifkan di Rumah Sakit untuk mengatasi larangan visite oleh dokter umum dan DPJP yg tidak kooperatif - SDM dan direktur → kumpulkan dan identifikasi kompetensi seluruh DPJP yang dapat di lakukan sharing kompetensi. Apabila terdapat GAP bisa di koordinasikan dengan PT	
3	Optimalisasi segmen non JKN	MCU rumah sakit	- Buat divisi sendiri yang tidak tercampur dengan rumah sakit - marketing sendiri yang bisa cover untuk all rumah sakit	- Manajerial PT - Manajerial RS

			- coba di koordinasikan dan di diskusikan antara PT dan Rumah Sakit terkait program dan tarifnya - MCU nantinya di bawah PT	
4	RS Prima Husada Sukorejo	1. APM 2. Langkah dalam meningkatkan kunjungan rawat jalan 3. Bagaimana cara agar tidak terkena audit 4. KTD yg berhubungan dengan control → kebijakan dir rs untuk pasien post ranap dan rajal sehingga tidak ada resiko baik secara medis maupun finansial 5. Klaim tidak layak karena episode perawatan 6. Kebijakan pasien dengan lebih dari 1 penyakit kronis dengan HD	1. Buat target kapan bisa full penggunaan APM (untuk efisiensi) 2. Bisa efisiensi dalam penambahan jam libur 3. Humas → gencarkan kunjungan ke Perusahaan karena karyawan punya BPJS. Segmen RS untuk berfokus pada Perusahaan 4. Perencanaan DPJP → analisis internal dan kebijakan untuk dokter baru minimal 4 jam 5. Mitigasi jumlah SEP yg harus di approval → memahami unit agar tidak terjadi klaim tidak layak untuk episode perawatan 6. HD → dilakukan rujuk balik untuk penyakit kronis sehingga penyakit kronis ditangani di FKTP 7. PPK CP → harus dilakukan oleh semua 8. Analisis kebutuhan SDM terutama DPJP dalam perencanaan setahun 9. Supervisi terkait edukasi terhadap pasien 10. Perbaikan perumusan kebutuhan ABK harus selaras antara PT hingga unit	

5	RS Prima Husada Malang	1. Penurunan kunjungan terjadi di semua RS 2. IMP RS 3. Just culture	1. Poli spesialis → efisiensi jadwal DPJP → mampatkan jadwal 2. Perbaikan IMP RS disampaikan termasuk hasil analisisnya 3. List kebutuhan penambahan sarana prasarana 4. Just culture yg diberikan punishment akan mengurangi poin → tetapi tetap bisa di analisis apakah human eror atau bukan 5. Orientasi staf baru → orientasi tentang SPO, pedoman dan kebijakan kebijakan rs, termasuk terkait etika	1. SDM 2. Manajerial RS
---	------------------------	--	--	----------------------------

Pemimpin Rapat

Malang, 12 Maret 2026

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Sadi Hariono, MMRS
Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur PT Disa Prima Medika


dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

DOKUMENTASI

